

PROTOCOLO DE ACESSO PARA FONAUDIOLOGIA E EXAMES AUDITIVOS



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

2025



MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Franci Maiara Machado

COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski

ELABORAÇÃO - 2025

Marineide Cruz Tonin

COLABORAÇÃO – 2024/2025

Aline Gomes de Franca - CEREST

Aline Deschamps - Atenção Primária à Saúde

Ana Carolina Xavier - Centrinho Fissura

Ana Luisa Molz - Sasa Centrinho

Ariane Luswargui Farina - Atenção Primária à Saúde

Daiane Rodrigues Pereira Gomes - Atenção Primária à Saúde

Erika Paula De Souza Leal - SASA Centrinho

Juliana Fracalosse Garbino - Centrinho Fissura

Gabriel Luckmann - NGQP

Giane Margarete Chiarelli Rolim Nakad - NAIPE DI/TEA

Karen Adriana Marques da Silva - SER

Larissa Dobner da Rosa - Centrinho Fissura

Miriam Leonardo Rocha - SER

Natalie Leonardo Rocha - Atenção Primária à Saúde

Patricia Pacheco - SASA Centrinho

Suelen Naiara Batista da Silva - Atenção Primária à Saúde

Tatiane Dominoni Rodrigues - NAIPE DI/TEA



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	7
2. ORIENTAÇÕES GERAIS DE ENCAMINHAMENTO À AVALIAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA..	8
2.1. Informações necessárias que devem constar no encaminhamento.....	8
2.2. Profissionais que podem realizar o encaminhamento	9
2.3. Classificação de Prioridade da Regulação.....	9
Quadro 01. Classificação das Prioridades dos usuários para Avaliação Fonoaudiológica pela regulação.....	9
3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ENCAMINHAMENTO À TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA PELO PRESTADOR CONTRATUALIZADO.....	11
3.1. Informações necessárias que devem constar no encaminhamento.....	11
3.2. Profissionais que podem realizar o encaminhamento.....	11
3.3. Classificação de Prioridade da Regulação.....	11
Quadro 02. Classificação das prioridades para o prestador contratualizado para acesso a Terapia Fonoaudiológica.....	11
4. ORIENTAÇÕES GERAIS DE ENCAMINHAMENTO PARA EXAMES AUDITIVOS.....	13
4.1. Informações necessárias que devem constar no encaminhamento.....	13
4.2. Profissionais que podem realizar o encaminhamento.....	14
4.3. Classificação de Prioridade da Regulação.....	14
Quadro 03. Classificação das Prioridades para procedimentos de Exames Auditivos.....	14
5. PROCEDIMENTOS REGULADOS PELO ESTADO.....	15
Quadro 04. Procedimentos regulados pelo Estado.....	16
6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DE ACESSO AOS SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS.....	16
Quadro 05. Critérios de Exclusão.....	16
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO.....	16
7. DESCRIÇÃO E INDICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS.....	19
Quadro 06. Descrição e Critérios de Solicitação dos Procedimentos Fonoaudiológicos.....	19
8. INDICAÇÃO DE EXAMES AUDIOLÓGICOS DE ACORDO COM FAIXA ETÁRIA.....	22
Quadro 07. Descrição dos procedimentos audiológicos por faixa etária.....	22
ANEXOS.....	26
Anexo 01. Fluxo de Acesso à Consulta em Fonoaudiologia.....	26
Anexo 02. Fluxo para usuário de prótese auditiva que acessa os serviços de saúde que não o SASA/Centrinho.....	27
Anexo 03. Fluxo para usuário com suspeita ou confirmação de perda auditiva.....	28
Anexo 04. Fluxo para Solicitação de Exames Auditivos.....	29
Anexo 05. Teste da orelhinha não realizada no local de nascimento.....	30
Anexo 06. Fluxo de Encaminhamento da Criança com Dificuldade na Amamentação.....	31

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

AASI: Aparelho de Amplificação Sonora Individual

ABR: Auditory brainstem response/Audiometria de tronco encefálico

ADNPM: Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor

APS: Atenção Primária à Saúde

BERA (ou PEATE): Brainstem Evoked Response Audiometry/Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico

COMUSA: Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva

dB: Decibel

EOA: Emissões Otoacústicas Evocadas

HIJG: Hospital Infantil Joana de Gusmão

Hz: Unidade Hertz

IPRF: Índice Percentual de Reconhecimento de Fala

IRDA: Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva

KHz: KiloHertz

LDV: Limiar de Detecção de Voz

LRF: Limiar de Reconhecimento de Fala

NAIPE: Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo

Nº: Número

ORL: Otorrinolaringologia

PCD: Pessoa com Deficiência

PEATE: Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico

PFT: Prova da Função Tubária

PMV: Procedimento Municipal Vinculado

PSE - Programa de Saúde do Escolar

SASA: Serviço Ambulatorial de Saúde Auditiva

SC: Santa Catarina

SEI: Sistema Eletrônico de Informação

SER: Serviço Especializado em Reabilitação

SIG-SaudeTech: Sistema Integrado de Gestão

SUS: Sistema Único de Saúde

TANU: Triagem Auditiva Neonatal Universal

TDI: Transtorno do Déficit Intelectual

TDH 39- Telephonics Dynamic Headphone Modelo 39

UBSF: Unidade Básica de Saúde da Família

VRA: Audiometria de Reforço Visual

TEA: Transtorno do Espectro Autista

1. INTRODUÇÃO

A atuação da Fonoaudiologia na Atenção Primária à Saúde (APS) é estratégica para a promoção da saúde e prevenção de agravos relacionados à comunicação humana e à deglutição, contribuindo de forma decisiva para a integralidade do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS). A identificação precoce de alterações na linguagem oral e escrita, fala, voz, audição e deglutição permite a adoção de condutas que minimizam riscos, otimizam o desenvolvimento comunicativo e favorecem a qualidade de vida ao longo das fases da vida.

Na Atenção Secundária, o papel do fonoaudiólogo assume caráter mais especializado, com enfoque no diagnóstico e tratamento de condições que demandam intervenções específicas e complexas. Nesses níveis de atenção, a organização e a regulação dos procedimentos fonoaudiológicos tornam-se essenciais para garantir o acesso oportuno, equânime e resolutivo aos serviços.

Considerando a complexidade e a diversidade das demandas, a oferta de terapias fonoaudiológicas também pode ocorrer por meio de serviços contratualizados, devidamente habilitados e regulados pelo município. Dessa forma, o acesso à terapia em serviço contratualizado assegura ao usuário a integralidade do tratamento, respeitando os princípios de universalidade, equidade e regionalização da atenção à saúde.

A crescente demanda por atendimentos especializados, aliada à diversidade de perfis clínicos e às particularidades locais, impõe desafios à gestão de listas de espera e aos fluxos assistenciais. Nesse contexto, faz-se necessária a construção de diretrizes claras e fundamentadas para nortear as práticas de regulação.

Este documento apresenta um protocolo de procedimentos fonoaudiológicos voltado à regulação em saúde, na forma de um guideline: um conjunto de recomendações baseadas em evidências científicas e consensos técnicos, que orientam a tomada de decisão clínica e administrativa. As diretrizes aqui dispostas têm caráter abrangente e flexível, respeitando o julgamento profissional e as especificidades de cada território. Seu objetivo é subsidiar critérios de triagem e priorização que garantam a alocação eficaz dos recursos disponíveis, assegurando cuidado oportuno e qualificado aos usuários do SUS.

A Atenção Primária à Saúde (APS), enquanto ordenadora do cuidado, é responsável por acolher e organizar diversas demandas que envolvem encaminhamentos e direcionamentos dentro da rede de saúde. Nesse contexto, as solicitações para avaliação fonoaudiológica são encaminhadas ao profissional fonoaudiólogo com o objetivo de investigar queixas ou identificar possíveis alterações relacionadas à fala,

linguagem oral e escrita, voz, audição, deglutição, entre outras.

Essas solicitações podem ter diversas origens, tais como:

- Pelo próprio usuário, por demanda espontânea ou por encaminhamento de profissionais externos ao SUS;
- Pela equipe médica e/ou multiprofissional da unidade de saúde;
- Pela escola, a partir de solicitações após falha nas triagens do Programa Saúde na Escola (PSE);
- Pela equipe de saúde, com base nas demandas identificadas durante o cuidado;
- Por contrarreferência de instituições hospitalares, após alta ou quando identificada nova necessidade;
- Por transferência de cuidado de procedimentos iniciados em outros municípios ou regiões;
- Pela necessidade de continuidade do cuidado após alta de serviços especializados;
- Outras situações pertinentes identificadas na prática clínica.

2. ORIENTAÇÕES GERAIS DE ENCAMINHAMENTO À AVALIAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA

Usuários identificados com queixas na comunicação oral, linguagem, leitura e escrita, voz ou funções estomatognáticas, serão encaminhadas conforme **Anexo 01. Fluxo de Acesso à Consulta em Fonoaudiologia** e **Anexo 06. Fluxo de Encaminhamento da Criança com Dificuldade na Amamentação**.

Procedimento: 99000754 - Consulta em Fonoaudiologia Avaliação.

2.1. Informações necessárias que devem constar no encaminhamento

- ✓ Descrever história clínica, sinais e sintomas, tempo de evolução;
- ✓ Comorbidades, uso de medicações;
- ✓ Descrição da queixa, exemplos: Atraso no desenvolvimento da fala e linguagem, trocas de fonemas, disfluência (gagueira), dificuldades de aprendizagem, trocas na escrita, alterações orofaciais (disfagias, dificuldades na amamentação, dificuldades na alimentação) alterações vocais, etc;
- ✓ Terapêutica já utilizada e tempo de tratamento;
- ✓ Impacto no desenvolvimento, na aprendizagem, na função social, laboral;
- ✓ Descrever a condição do usuário.

2.2. Profissionais que podem realizar o encaminhamento

- ✓ Médicos;
- ✓ Enfermeiros (exclusivo para anquiloglossia ou encaminhamento externo com dados descritos acima);
- ✓ Fonoaudiólogos dos serviços especiais;
- ✓ Odontólogos;
- ✓ Profissionais da Equipe Multiprofissional (ver composição descrita no Manual da Equipe Multiprofissional na Atenção Primária à Saúde, disponível no processo SEI nº 23.0.029059-0).
- ✓ Prestador contratualizado após concluir o número de sessões, padronizado pelo município.

Importante: O Enfermeiro ou profissional da equipe e-multi da APS que receber um encaminhamento externo solicitando avaliação fonoaudiológica, e que nele constarem os dados descritos acima, poderão encaminhar este usuário para o fonoaudiólogo transcrevendo os dados descritos junto ao pedido via sistema SIG-Saudetech e identificando o profissional externo que encaminhou (nome e registro em Conselho de Classe). Se acaso não tiver uma descrição sucinta dos motivos do encaminhamento, então o usuário deverá passar por uma avaliação médica na APS.

2.3. Classificação de Prioridade da Regulação

Quadro 01. Classificação das Prioridades dos usuários para Avaliação Fonoaudiológica pela regulação.

CONDIÇÃO (*)	CLASSIFICAÇÃO DO USUÁRIO POR PRIORIDADE / FAIXA ETÁRIA		
	Prioridade 1 (Emergência)	Prioridade 2 (Urgência)	Prioridade 3 (Eletivo)
Disfagia ou risco de vida devido à restrição alimentar	independente da idade	-	-
Pós cirúrgico de Câncer de cabeça e pescoço	independente da idade	-	-
Suspeita de Frênulo lingual curto	lactente com até 12 meses e com prejuízo na amamentação e/ou alimentação	acima de 12 meses até 11 anos 11 meses e 29 dias	a partir de 12 anos sem impacto na deglutição
Disfluência (repetição ou prolongamento de sons, que alteram o curso normal da fala)	-	acima de 30 meses	acima de 12 anos
Atraso no desenvolvimento da fala e linguagem	-	independente da idade	-
Desvio fonético e/ou desvio fonológico	-	independente da idade	-
Suspeita ou com diagnóstico de Apraxia de fala	-	independente da idade	-

CONDIÇÃO (*)	CLASSIFICAÇÃO DO USUÁRIO POR PRIORIDADE / FAIXA ETÁRIA		
	Prioridade 1 (Emergência)	Prioridade 2 (Urgência)	Prioridade 3 (Eletivo)
Doenças neurodegenerativas ou doenças neuromotoras e usuário deambulando, sem critérios para o SER	-	independente da idade	-
Afasia em decorrência de injúria neurológica e usuário deambulando	independente da idade até 6 meses após a lesão	independente da idade a partir de 6 meses da lesão	-
Suspeita ou confirmação de alteração no exame do Processamento Auditivo Central	-	de 7 a 12 anos 11 meses e 29 dias	a partir dos 13 anos
Dificuldade de aprendizagem, leitura e escrita	-	de 7 a 12 anos 11 meses e 29 dias	a partir dos 13 anos
Paralisia facial periférica ou central	-	independente da idade até 6 meses após o evento	independente da idade a partir de 6 meses do evento
Tratamento ortodôntico com comprometimento orofacial e sem alterações das vias aéreas superiores,	-	até 7 anos 11 meses e 29 dias	a partir de 8 anos
Pós cirúrgico de Adenoidectomia ou Tonsilectomia	-	-	independente da idade
Patologia vocal constatada em avaliação otorrinolaringológica	-	independente da idade	-
Pós cirúrgico Laríngeo	-	independente da idade até 3 meses da cirurgia	independente da idade após 3 meses da cirurgia
Hábitos orais parafuncionais (Ex: sucção de dedo ou chupeta)	-	-	independente da idade
Seletividade alimentar sem critérios para NAIPE ou SER	-	independente da idade	-
Usuários que acessaram, no máximo, 20 sessões de fonoterapia e que necessitam continuar atendimento com relatório de justificativa do prestador	independente da idade	-	-
Usuários que receberam alta dos serviços especializados e contra referenciados para a APS com demandas específicas para fono que não tenham critérios para reinserção no serviço conforme protocolo	-	-	independente da idade

Fonte: SMS, Joinville, 2024.

**Casos não descritos neste quadro estarão sujeitos a análise do Regulador.*

3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ENCAMINHAMENTO À TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA PELO PRESTADOR CONTRATUALIZADO

Usuários avaliados/triados pelo serviço de fonoaudiologia do município em que é detectado a necessidade de atendimento fonoaudiológico sistemático, a partir das queixas identificadas na comunicação oral, linguagem, leitura e escrita, voz ou funções estomatognáticas, devem ser encaminhados à fonoterapia com um prestador contratualizado.

Procedimento: 99002911 - Terapia Fonoaudiológica (PMV).

3.1. Informações necessárias que devem constar no encaminhamento

- ✓ Hipótese diagnóstica;
- ✓ Descrever história clínica, sinais e sintomas, tempo de evolução;
- ✓ Comorbidades
- ✓ Uso de medicações;
- ✓ Descrição da queixa;
- ✓ Terapêutica já utilizada e tempo de tratamento;
- ✓ Impacto no desenvolvimento, aprendizagem, laboral, social.
- ✓ Descrever a condição do usuário.

3.2. Profissionais que podem realizar o encaminhamento

- ✓ Serviço de fonoaudiologia da Atenção Primária à Saúde do município, após primeiro atendimento, avaliação ou reavaliação.

3.3. Classificação de Prioridade da Regulação

Quadro 02. Classificação das prioridades para o prestador contratualizado para acesso a Terapia Fonoaudiológica

CONDIÇÃO (*)	COMO CLASSIFICAR O USUÁRIO		
	Prioridade 1 (Emergência)	Prioridade 2 (Urgência)	Prioridade 3 (Eletivo)
Disfagia ou risco de vida devido à restrição alimentar	independente da idade	-	-
Pós cirúrgico de câncer de cabeça e pescoço	independente da idade	-	-
Disfluência (repetição ou prolongamento de sons, que alteram o curso normal da fala)	-	acima de 30 meses até 11 anos 11 meses e 29 dias	acima de 12 anos



CONDIÇÃO (*)	COMO CLASSIFICAR O USUÁRIO		
	Prioridade 1 (Emergência)	Prioridade 2 (Urgência)	Prioridade 3 (Eletivo)
Atraso no desenvolvimento da fala	-	independente da idade	-
Desvio fonético e/ou desvio fonológico	-	independente da idade	-
Suspeita ou com diagnóstico de Apraxia de fala	-	independente da idade	-
Transtorno específico do desenvolvimento da fala e da linguagem sem critérios para NAIPE ou SER	-	para usuários com persistência do quadro - de 30 meses a 5 anos	de 30 meses a 5 anos após primeiro atendimento e acesso às 20 sessões, devendo retornar ao fonoaudiólogo da APS para reavaliações periódicas
Usuário após completar 20 sessões de terapia fonoaudiológica no prestador contratualizado e que necessitam continuidade (exceto os casos em que o Fonoaudiólogo assistente justifique a necessidade de priorização)	-	-	independente da idade
Usuário com alterações fonoaudiológicas que acarretam risco à vida com condições de deslocamento ao Serviço de atendimento fonoaudiológico sem prejuízo à saúde	independente da idade	-	-
Doenças neurodegenerativas ou doenças neuromotoras e usuário deambulando, sem critérios para o SER	-	independente da idade	-
Afasia em decorrência de injúria neurológica e usuário deambulando	independente da idade até 6 meses após a lesão	independente da idade a partir de 6 meses da lesão	-
Suspeita ou confirmação de alteração no exame do Processamento Auditivo Central	-	de 7 a 11 anos 11 meses e 29 dias	acima de 12 anos
Dificuldade de aprendizagem, leitura e escrita	-	de 7 a 11 anos 11 meses e 29 dias	acima de 12 anos
Paralisia facial periférica ou central	-	independente da idade até 6 meses após o evento	independente da idade a partir de 6 meses do evento
Tratamento ortodôntico com comprometimento orofacial e sem alterações das vias aéreas superiores	-	até 7 anos 11 meses e 29 dias	a partir de 8 anos
Pós cirúrgico de Adenoidectomia ou Tonsilectomia	-	-	independente da idade

CONDIÇÃO (*)	COMO CLASSIFICAR O USUÁRIO		
	Prioridade 1 (Emergência)	Prioridade 2 (Urgência)	Prioridade 3 (Eletivo)
Patologia vocal constatada em avaliação otorrinolaringológica com impacto laboral	-	independente da idade	-
Pós cirúrgico Laríngeo	independente da idade até 3 meses da cirurgia	-	-
Trocas esperadas para a faixa etária	-	-	até 5 anos
Hábitos orais parafuncionais (Ex: sucção de dedo ou chupeta)	-	-	independente da idade
Seletividade alimentar sem critérios para NAIPE ou SER		independente da idade	-
Usuários que receberam alta dos serviços especializados e contra referenciados para a APS com demandas específicas para fonoaudiologia que não tenham critérios para reinserção no serviço conforme protocolo	-	-	independente da idade

Fonte: SMS, Joinville, 2025.

*Casos não descritos neste tópico estarão sujeitos a análise do Regulador.

4. ORIENTAÇÕES GERAIS DE ENCAMINHAMENTO PARA EXAMES AUDITIVOS

Procedimentos indicados para os usuários com queixas auditivas, suspeita ou diagnóstico de perdas auditivas, ou para Triagem Auditiva Neonatal Universal não realizada no seu local de nascimento.

Para realizar encaminhamentos para teste da orelhinha não realizada no local de nascimento, segue-se o **Anexo 05**.

Procedimentos: Conforme descrito no Quadro 03

4.1. Informações necessárias que devem constar no encaminhamento

- ✓ Descrever história clínica, sinais e sintomas, tempo de evolução;
- ✓ Comorbidades, uso de medicações;
- ✓ Descrição da queixa;
- ✓ Dados de otoscopia;
- ✓ Impacto no desenvolvimento, na aprendizagem, na função laboral, social;
- ✓ Descrição da ocupação laboral para usuários entre 17 e 65 anos;
- ✓ Para análise de faixa etária x procedimentos utilizar parâmetros de quadro 6.

4.2. Profissionais que podem realizar o encaminhamento

- ✓ Médicos;
- ✓ Fonoaudiólogos;
- ✓ Enfermeiros (somente para o Teste da Orelhinha - 211070149 - Emissões otoacústicas para Triagem Auditiva).

4.3. Classificação de Prioridade da Regulação

Quadro 03. Classificação das Prioridades para procedimentos de Exames Auditivos

Código	Nomenclatura do Exame no SIG-SaudeTech	Prioridade 1	Prioridade 2	Prioridade 3
211070149	Emissões Otoacústicas Evocadas Para Triagem Auditiva (Teste da Orelhinha)	Bebês até 6 meses que não realizaram Triagem Auditiva Neonatal sem IRDA	-	-
0211070157	Estudo de Emissões Otoacústicas Evocadas Transitórias e Produtos de Distorção (EOA)	Bebês, acima de 6 meses, que não realizaram Teste da Orelhinha no local de nascimento sem IRDA; Para diagnóstico audiológico quando sem sucesso em outro procedimento	Para monitoramento auditivo; Para diagnóstico audiológico complementar.	-
0211070033	Audiometria em Campo Livre	-	Sem condições de resposta com fone auricular (p.e. modelo TDH 39);	Avaliar respostas de pesquisa tonal ou de recepção de fala com AASI
0211070211	Logaudiometria (LDV-IPRF-LRF)	Acompanha prioridade da audiometria tonal	Acompanha prioridade da audiometria tonal	Acompanha prioridade da audiometria tonal
0211070050	Avaliação Auditiva Comportamental	Bebês que passaram na TANU e com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) conforme COMUSA e que necessitam de monitoramento auditivo, a partir do 6º mês de vida	Bebês menores que o 6º mês de vida que passaram na TANU e com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) conforme COMUSA e que necessitam de monitoramento auditivo.	-

Código	Nomenclatura do Exame no SIG-SaudeTech	Prioridade 1	Prioridade 2	Prioridade 3
0211070041	Audiometria Tonal Limiar (Via Aérea / Óssea)	2 a 16 anos 11 meses e 29 dias, independente da queixa; Adultos com perdas auditivas súbitas (uni ou bilaterais); Maiores de 80 anos; Patologias de Orelha média; Pré operatório Otológico; Usuário com uso de ototóxico, para monitoramento auditivo; Para repriorização da fila de espera para SASA / Centrinho	De 17 anos a 60 anos com queixas otológicas, exceto perdas súbitas; Queixa de zumbido; Abaixo de 80 anos para identificar critérios para encaminhamento ao SASA / Centrinho; 61 a 79 anos com perdas auditivas já instaladas, para monitoramento auditivo;	Deficientes auditivos para laudos de PCD ou passe bus
0211070203	Imitanciometria	Perdas condutivas, perfuração timpânica unilateral, queixas, tontura, vertigens; Patologias de Orelha média; Pré operatório	Queixa de zumbido	Acompanha prioridade da audiometria tonal
0211070289	Prova De Função Tubária	Prioridade segue a mesma dada na imitanciometria	-	-
0211070343	Testes de Processamento Auditivo	Usuários em atendimento fonoaudiológico já com audiometria e imitanciometria prévia realizada (máximo de 30 dias).	Para diagnóstico diferencial com solicitação de especialista (ORL, Neuro, Psiquiatria, Pediatria e Fonoaudiologia)	Após alta do tratamento fonoaudiológico para comparativo.
99991200	Vecto-Eletronistagmografia	Tontura, vertigem, enjôo	Zumbido	-
0211050113	Potencial Evocado Auditivo (PEATE)	Bebês a partir do 6º mês de vida que passaram na TANU e com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) conforme COMUSA e que necessitam de monitoramento auditivo; Bebês menores que o 6º mês de vida que passaram na TANU (triagem auditiva somente com EOA) e com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) conforme COMUSA e que necessitam de monitoramento auditivo; Crianças com suspeita de perda auditiva que não respondem / colaboram para audiometria tonal limiar. Bebês que não realizaram a TANU no local de nascimento com IRDA	Bebês, menores que 6º mês de vida, que passaram na TANU (triagem auditiva com PEATE Automático) e com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) conforme COMUSA e que necessitam de monitoramento; Para diagnóstico audiológico diferencial ou complementar; Perda auditiva unilateral ou assimétricas;	Bebês que passaram na TANU e sem Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) conforme COMUSA;

Fonte: SMS, Joinville, 2025.

5. PROCEDIMENTOS REGULADOS PELO ESTADO

Para realizar encaminhamento para saúde auditiva seguir **Anexo 02.** Fluxo para usuário de prótese auditiva que acessa os serviços de saúde que não o SASA/Centrinho, **Anexo 03.** Fluxo para usuário com suspeita ou confirmação de perda auditiva e **Anexo 04.** Fluxo para Solicitação de Exames Auditivos.

Quadro 04. Procedimentos regulados pelo Estado

CÓDIGO	NOMENCLATURA DO EXAME NO SIG-SAUDETECH	CRITÉRIOS
0211070092	AValiação PARA DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA	Protocolos de acesso Estadual (*)
030101007	CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA – FISSURA LÁBIO PALATAL	Protocolos de acesso Estadual (*)

(*) Acessar a página do Estado-SC

6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DE ACESSO AOS SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS.

Os procedimentos a seguir dizem respeito aos critérios de exclusão para os atendimentos de avaliação, terapia fonoaudiológica e exames auditivos.

Quadro 05. Critérios de Exclusão

PROCEDIMENTO	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	CONDUTA	LOCAL
Avaliação e Terapia Fonoaudiológica	Usuários em atendimento fonoaudiológico na rede, em qualquer serviço especializado	Aguardar término do atendimento especializado com contra referência do Serviço Especializado e justificativa da continuidade do tratamento	-
	Usuário deficiente auditivo (qualquer idade) para reabilitação e/ou adaptação de aparelho de Amplificação Sonora Individual recebido pelo SUS de SC.	Orientar o usuário a procurar o agendamento diretamente no SASA Centrinho (Presencial ou via telefônico)	SASA CENTRINHO
	Usuário com Implante Coclear não realizado pelo SUS	Direcionar para empresa/Instituição que realizou o implante Coclear	-
	Usuário com Transtorno do Déficit intelectual e que não acessou o NAIPE	Encaminhar ao NAIPE	SEI nº 22.0.178204-5
	Usuário com diagnóstico de TEA e que não acessou o NAIPE	Encaminhar ao NAIPE	SEI nº 22.0.178204-5
	Usuário com atraso DNPM e alterações neurológicas que não acessou o SER	Encaminhar ao SER	SEI nº 18.0.027664-5

PROCEDIMENTO	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	CONDUTA	LOCAL
	Usuário TEA não verbal, já avaliados pelo serviço especializado	Somente o NAIPE define a continuidade do acompanhamento. Solicitar contrarreferência do Serviço	-
	Usuário do serviço de oncologia do HMSJ	Orientar a acessar o fonoaudiólogo do ambulatório de oncologia do HMSJ	Ambulatório de Oncologia do HMSJ
Audiometria Tonal e Logaudiometria	Trabalhadores na faixa etária de 17 a 65 anos com história pregressa ou atual de exposição a níveis de intensidade sonora elevados ou produtos químicos	Encaminhar ao CEREST	Processo SEI 20.0.194762-8 - Memorando SEI 7911392/2020 e Protocolos de acesso SEI 7911580 e 9612795.
	Usuários com prótese auditiva recebido pelo SUS de Santa Catarina	Orientar o usuário a procurar o agendamento diretamente no SASA Centrinho (Presencial ou via telefônico)	-
	Usuários com audiometria realizada pelo SUS nos últimos 90 dias. Em casos de necessidade de repetição do exame, justificar no encaminhamento.	Aguardar período carência estipulado pelo sistema SIG-Saudetech	-
	Usuários com idade inferior a 24 meses ou sem condições neurológicas maturacionais para respostas comportamentais	Avaliar qual procedimento mais adequado conforme faixa etária (Quadro 6)	-
Imitanciometria (Medidas de Imitância Acústica)	Usuários com tubo de ventilação	Encaminhar ao ORL	ORL pediátrica até 14a 11m 29 dias ORL adulto: > ou = 15 anos
	Usuários com perfuração timpânica bilateral, possível de visualização	*Se a solicitação for do ORL devolver solicitando confirmação do pedido do procedimento. Autorização a critério do Regulador	-
Emissões Otoacústicas Transiente Ou Produto de Distorção	Usuários com alteração de orelha média comprovada em exame de imagem ou Medida de Imitância Acústica	Impedimento para realização do exame.	-
	Usuários com audiometria evidenciando perdas auditivas com limiares tonais maiores que 40dB	ORL	-
	Usuários com Implante Coclear bilateral	Sem indicação para o procedimento	-
	Usuário que não realizou a TANU no local do nascimento com IRDA	Solicitar o PEATE	

PROCEDIMENTO	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	CONDUTA	LOCAL
Potencial Evocado Auditivo (PEATE/BERA)	Criança de até 6 meses que realizou Triagem Auditiva neonatal com PEATE Automático e com resultado de PASSA registrado na carteira de saúde da criança e sem IRDA.	Avaliação Auditiva Comportamental	Conforme item 03 deste protocolo
	Recém-Nascido que realizou Triagem Auditiva Neonatal com resultado de FALHA registrada na carteira de saúde da criança	Solicitar via SIG-Saudetech o procedimento 0211070092- AVALIAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA	SASA / Centrinho
Teste de Processamento Auditivo Central	Sem resultado ou pedido de audiometria tonal, logaudiometria e imitanciometria	Devolver para solicitação dos exames: audiometria tonal, logaudiometria e imitanciometria	SEI 210087910-8
	Idade inferior a sete anos	Sem critério para realização do teste	SEI 210087910-8
	Habilidades cognitivas e linguísticas insuficientes para a compreensão das tarefas	Sem critério para realização do teste	SEI 210087910-8
	Limiares audiométricos apresentando perdas auditivas a partir da classificação moderada	Sem critério para realização do teste	SEI 210087910-8
	Presença de alterações de orelha média no momento da avaliação (timpanograma tipo B ou C em uma ou ambas as orelhas)	Sem critério para realização do teste Encaminhar para UBSF / ORL	SEI 210087910-8
	Produção articulatória ininteligível	Sem critério para realização do teste	SEI 210087910-8
	Nível de atenção incompatível com as tarefas	Sem critério para realização do teste	SEI 210087910-8
Vecto-Eletronistagmografia	Faixa etária inferior a 7 anos	-	-
AVALIAÇÃO PARA/ DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA	Bebês com IRDA , registrado na carteira de saúde da criança com resultado de “ PASSA ” no teste da orelhinha realizado apenas com EOA.	Solicitar PEATE - Potencial Evocado Auditivo	Conforme item 4.3 deste protocolo
	Bebês com IRDA , registrado na carteira de saúde da criança com resultado de “ PASSA ” no teste da Orelhinha realizado com PEATE Automático	Solicitar Monitoramento auditivo (de acordo com o quadro 6) a partir do 3º mês ou 6º mês de acordo com COMUSA (quadro 6)	-
	Bebês sem IRDA com resultado de “ PASSA ”, registrado na carteira de saúde da criança, no teste da Orelhinha	Solicitar monitoramento auditivo (Via SIG-Saudetech), se necessário, a critério médico (quadro 6)	-

PROCEDIMENTO	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	CONDUTA	LOCAL
	Usuários que já acessaram o SASA Centrinho com concessão ou não da prótese auditiva pelo SUS de SC	Orientar o usuário a procurar o agendamento diretamente no SASA Centrinho (Presencial ou via telefônico)	-
CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA – FISSURA LÁBIO PALATAL	Alterações craniofaciais sem presença de fenda labial, palatal ou labiopalatal	Conforme acessos definidos pelo Estado	-
	Fenda labial ou palatal adquirida	Cirurgia Plástica ou Buco Maxilo ou Cabeça e Pescoço	-

Fonte: SMS, Joinville, 2025.

7. DESCRIÇÃO E INDICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS

Quadro 06. Descrição e Critérios de Solicitação dos Procedimentos Fonoaudiológicos

CÓDIGO	NOMENCLATURA DO PROCEDIMENTO NO SIG-SAUDETECH	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO
211070149	Emissões Otoacústicas Evocadas Para Triagem Auditiva (Teste Da Orelhinha)	EOA transientes; Utilizados na Triagem Auditiva Neonatal (teste da orelhinha), mas podem ser utilizados para avaliação clínica da funcionalidade da cóclea (sistema auditivo periférico); Código específico para solicitação da enfermagem	Bebês que não realizaram Triagem Auditiva Neonatal (teste da orelhinha)
0211070157	Estudo De Emissões Otoacústicas Evocadas Transitorias E Produtos De Distorção (EOA)	Dois tipos: EOA transientes e EOA produto de Distorção; Utilizados na Triagem Auditiva Neonatal (teste da orelhinha), mas podem ser utilizados para avaliação clínica da funcionalidade da cóclea (sistema auditivo periférico); Não define limiar audiológico, apenas função coclear, mas prediz alterações auditivas; Teste rápido, não invasivo e de fácil execução, não necessitando de grandes preparos; Deve estar associado a timpanometria quando alterado; Outras nomenclaturas comumente usadas: Teste da Orelhinha, Emissões Otoacústicas, EOA, EOA T, EOA PD	Como complementar no diagnóstico de perdas auditivas (crianças e adultos); Nos trabalhadores expostos a ruído ou produto químico

CÓDIGO	NOMENCLATURA DO PROCEDIMENTO NO SIG-SAUDETECH	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO
0211070041	Audiometria Tonal Limiar (Via Aérea / Ossea)	Teste realizado em cabina acústica, Considerado o teste “padrão ouro” da avaliação auditiva; Pesquisa os limiares tonais nas frequências de 250Hz a 8000Hz pela via aérea e via óssea, garantindo a definição do tipo e grau da perda auditiva; Sugere-se incluir os testes de fala (logaudiometria) e a imitanciometria, para um diagnóstico completo; Exame que depende da resposta do usuário e que pode ser executado com estratégias lúdicas, adaptadas para crianças com alterações globais; Outras nomenclaturas comumente usadas: Áudio; Audiometria clínica; Audiometria Tonal; Pesquisa Limiar, audiometria lúdica (para crianças)	Suspeita de perda auditiva; Para encaminhamento ao Centrinho (SASA); Nos trabalhadores expostos a ruído ou produto químico; Monitoramento auditivo
0211070203	Imitanciometria	Exame que avalia o funcionamento da orelha média; Composto pela Timpanometria e a Pesquisa de Reflexo Acústico; Faz parte do “padrão ouro” da avaliação auditiva; Exame objetivo com participação mínima do usuário; Não necessita preparo; Outras nomenclaturas comumente usadas: Impedanciometria, Impê, Medidas de Imitância Acústica	Faz parte da bateria “padrão ouro” Indicada para avaliar a função de orelha média e função central aferente/eferente; Exame complementar a audiometria tonal liminar
0211070211	Logaudiometria (LDV-IPRF-LRF)	Pesquisa da recepção e discriminação da fala; Compõe a bateria de testes da audiometria clínica; Não pode ser solicitado isoladamente, pois seus resultados devem corroborar os limiares auditivos; Assim, deve-se realizar audiometria tonal liminar em conjunto pois necessita dos resultados das médias tritonaais; Outras nomenclaturas comumente usadas: Testes de fala; Teste Vocal	Faz parte da audiometria clínica (tonal e vocal).
0211070033	Audiometria Em Campo Livre	Pesquisa de limiar auditivo em cabina acústica, utilizando caixas de som e não fones supra aurais; Utilizada para avaliação em bebês a partir de 6 meses (técnicas compostas) e para avaliação do benefício de próteses auditivas; Exame que depende da interação do usuário, mas que pode ter estratégias facilitadoras como o reforço visual (brinquedos luminosos) para avaliar a localização sonora; Outras nomenclaturas comumente usadas: Audiometria em campo, Áudio em campo.	Indicada para avaliar bebês a partir de 6 meses; Indicada para avaliar ganho de próteses auditivas

CÓDIGO	NOMENCLATURA DO PROCEDIMENTO NO SIG-SAUDETECH	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO
0211070025	Audiometria De Reforço Visual (Via Aerea / Ossea)	Consiste na realização de Audiometria Tonal (Via Aérea/Óssea) com reforço visual; Avaliação indicada para bebês e crianças; Utiliza -se de técnicas lúdicas ou reforço visual; Rastreia níveis mínimos de detecção a sons nas frequências de 500Hz, 1KHz, 2KHz e 4KHz; Outras nomensclaturas comumente usadas: Audiometria infantil, Audiometria lúdica VRA, Audiometria com reforço visual	Indicada para crianças ou usuários com dificuldades nas respostas motoras condicionadas.
0211070050	Avaliacao Auditiva Comportamental	Avaliam o comportamento da criança, de acordo com a idade, considerando o desenvolvimento auditivo, em resposta a estímulos sonoros com espectro conhecido (p.e. instrumentos musicais - chocalho, tambor, etc, ou sons do ling); Outras nomensclaturas comumente usadas: comportamental	Indicada para avaliar bebês a partir de 6 meses
0211050113	Potencial Evocado Auditivo	Exame Eletrofisiológico que avalia parte da função auditiva central, especialmente na região de tronco cerebral. Informa sobre a funcionalidade do sistema auditivo periférico de forma indireta. Doas etapas: 1. Neurodiagnóstico: analisa a presença das ondas I-III-V em forte intensidade (80 dB ou mais) e a análise das latências das ondas I, III e V com estímulo click (espectro composto), que compreende as frequências de 2 a 4 KHz; 2. Pesquisa de Limiar Eletrofisiológico: analisa a mínima intensidade capaz de promover funcionamento auditivo central (presença de onda V), subsidiando informações sobre nível mínimo de audição (limiar) nas frequências pesquisadas - estímulo click (2-4KHz) ou estímulo tone burst (frequências específicas: 500, 1000, 2000 e/ou 4000Hz); Indicações: 3. diagnóstico audiológico em bebês com FALHA no teste da orelhinha ou com indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA), conforme protocolo COMUSA ; 4. crianças que não respondem a audiometria convencional; 5. indicada para suspeita de alteração auditiva central (adulto, crianças); 6. no diagnóstico diferencial de perdas assimétricas, dentre outras; Exame realizado com o usuário deitado e dormindo; Exige preparo de sono, o que pode ser difícil para algumas crianças maiores e/ou com alterações globais; Outras nomenclaturas comumente usadas: PEATE (Potencial Auditivo Evocado de Tronco Encefálico), BERA, Pesquisa eletrofisiológica da audição, ABR	Indicações: Diagnóstico audiológico em bebês que falharam no teste da orelhinha ou com indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA), conforme protocolo COMUSA; Crianças que não respondem a audiometria convencional; Indicada para suspeita de alteração auditiva central (adulto, crianças); No diagnóstico diferencial de perdas assimétricas, dentre outras
0211070289	Prova De Funcao Tubaria	Avalia permeabilidade da tuba auditiva; Faz parte da bateria da imitanciomertria; Não pode ser solicitado isoladamente;	Indicado para queixas de plenitude auricular,

CÓDIGO	NOMENCLATURA DO PROCEDIMENTO NO SIG-SAUDETECH	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO
		Outras nomenclaturas comumente usadas : Prova da função tubária, PFT	nos casos de perfuração de Membrana timpânica
0211070343	Testes De Processamento Auditivo	Bateria de testes comportamentais; Indicado para usuários com idade superior a 6 anos; Não é possível realizar em crianças com idade abaixo de 6 anos. Não há padrões de referência; Composto por vários testes que avaliam as habilidades auditivas; Necessário exames auditivos prévios recentes como audiometria tonal liminar, logoaudiometria e imitanciometria para avaliar aplicabilidade ou não da bateria; Indicada no diagnóstico audiológico e para nortear terapia fonoaudiológica; Outras nomenclaturas comumente usadas : APAC; PAC; Avaliação do Processamento Auditivo Central	Pré requisitos: Audiometria com resultados normais ou até perdas auditivas leves; Perdas moderadas somente quando simétricas; Imitanciometria prévia com resultados de curva timpanométrica tipo A
99991200	E.C.Vecto- Eletronistagmografia	Avaliação das funções vestibulares (equilíbrio); Outras nomenclaturas comumente usadas : Vecto, Otoneuro	Queixas de tontura, zumbido unilateral, outras a partir do 7 anos

Fonte: SMS, Joinville, 2025.

8. INDICAÇÃO DE EXAMES AUDIOLÓGICOS DE ACORDO COM FAIXA ETÁRIA

Quadro 07. Descrição dos procedimentos audiológicos por faixa etária

INDICAÇÃO DE EXAMES AUDIOLÓGICOS DE ACORDO COM FAIXA ETÁRIA						
0 a 1 mês	1 a 24 meses	2 a 5 anos	6 a 12 anos	12 a 17 anos	18 a 60 anos	acima de 60 anos
EOA TRANSIENTE (Teste da Orelhinha)	EOA TRANSIENTE E PRODUÇÃO DE DISTORÇÃO					
PEATE AUTOMÁTICO	PEATE DIAGNÓSTICO					
	AUDIOMETRIA COMPORTAMENTAL					
		AUDIOMETRIA LÚDICA				
	AUDIOMETRIA EM CAMPO					
		AUDIOMETRIA TONAL				
		LOGOAUDIOMETRIA				
			AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL			
			VECTONISTAGMOGRAFIA			
IMITANCIOMETRIA						

Fonte: SES, Joinville, 2025.

Protocolos do Estado para consulta:

SAÚDE AUDITIVA: [Saúde Auditiva](#)

FISSURA : [Protocolo de cirurgia plástica infantil](#)

Processos SEI para consulta:

EXAMES AUDITIVOS - Processo SEI nº 20.0.149111-0

NAIPE Processo SEI nº 22.0.178204-5

SER - Processo SEI nº 18.0.027664-5

ANQUILOGLOSSIA - Processo SEI Nº 210099867-0

PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL - Processo SEI Nº 210087910-8

CEREST - Processo SEI Nº 200194762-8

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Conselho Federal de Fonoaudiologia. Sistema de Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. **Cartilha SUS: Contribuição da Fonoaudiologia para o Avanço do SUS**. Brasília – DF: 2015;
- BRASIL. Conselho Federal de Fonoaudiologia. Sistema de Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. **Guia de Orientação na Avaliação Audiológica - Volume I - 2ª edição revisada e ampliada** - Brasília – DF: Julho, 2023;
- BRASIL. Conselho Federal de Fonoaudiologia. Sistema de Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. - **SIGTAP Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde** - Brasília – DF: 2024
- BRASIL. Conselho Federal de Fonoaudiologia. Sistema de Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. - **Guia De Orientação Na Avaliação Audiológica Volume II Eletrofisiologia E Eletroacústica**; Brasília – DF: Abril, 2022
- CECHINEL, C. **Regulação em saúde: um diálogo com o princípio da equidade**. Dissertação – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis: 2014;
- FERNANDES, J. S.; MOLZ, A. L.; BALSINI, D. C. T.; BALSINI, D. C. T.; ZIMMERMANN, F.; BARROZO, G. M. S.; HOFFMANN, J. **O caminho fonoaudiológico de um neonato na Rede Pública do município de Joinville no âmbito da saúde auditiva**. Revista – Multidisciplinar Em Saúde, 2(4), 285. Disponível em: <https://doi.org/10.51161/remis/3058>. 2021;
- GOULART, B. N. G.; CHIARI, B. M. **Construção e aplicação de indicadores de saúde na perspectiva fonoaudiológica: contribuições para reflexão**. Revista – Soc Bras Fonoaudiol, 11(3):194-204. 2006;
- LESSA, F. Fonoaudiologia e epidemiologia. In: Ferreira LP, Befi-Lopes DM, Limongi SCO, organizadores. **Tratado de fonoaudiologia**. São Paulo: Roca, p. 527-37. 2004;
- MANDRÁ, P. P.; DINIZ, M. V. **Caracterização do perfil diagnóstico e fluxo de um ambulatório de Fonoaudiologia hospitalar na área de Linguagem infantil**. Revista – Soc Bras Fonoaudiol, 16(2):121-5. 2011;
- MANDRÁ, P. P.; RIBEIRO, R. A. **Organização do serviço de fonoaudiologia no município de Ribeirão Preto**. Resumo – Revista Soc Bras Fonoaudiol, 13(Supl):467. 2008;
- MENDES, V. L. F. Acesso à saúde em fonoaudiologia. In: Befi-Lopes DM, organizadora. **Fonoaudiologia na atenção primária à saúde**. São Paulo, Lovise, 1997. p. 43-56. 2015;
- MOREIRA, M. D.; MOTA, H. B. **Os caminhos da fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde – SUS**. Revista – CEFAC, 11(3):516-21. 2009;

SAFFIER, I. P.; SILVA, M. V. C. B. **Consultas e exames na rede pública municipal do Rio de Janeiro via SISREG: desafios e alternativas de gestão para desafogar a demanda**. Academus Revista Científica da Saúde – 2(2):1-11. 2017;

SANTA CATARINA. Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. **Protocolos de Acesso da Regulação Estadual Ambulatorial**. Florianópolis – SC: 2020;

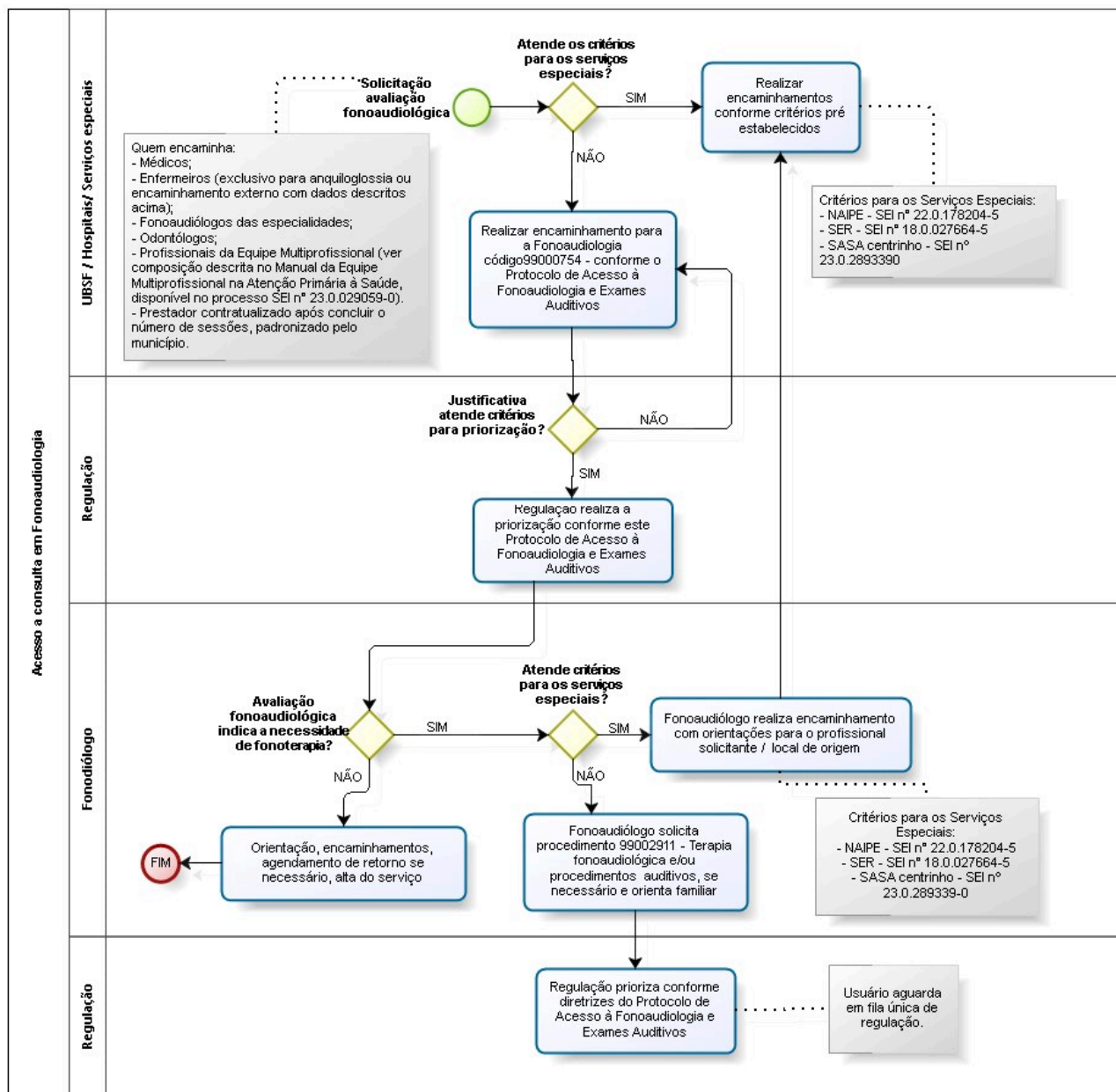
SANTA CATARINA. Secretaria Municipal de Saúde de Indaial. **Normatização do Setor de Fonoaudiologia - Atenção Especializada**. Indaial – SC: 2020;

SOUZA, R. R.; CAMPAGNONI, M.; AZEVEDO, C. N.; organizadores. **Agenda do gestor municipal de saúde: organizando o sistema a partir da atenção básica**. SES São Paulo – SP: 2009;

VILARINS, G. C. M.; SHIMIZU, H. E.; GUTIERREZ, M. M. U. **A Regulação em Saúde: aspectos conceituais e operacionais**. Debate – Saude, 36(95):640-647. 2012.

ANEXOS

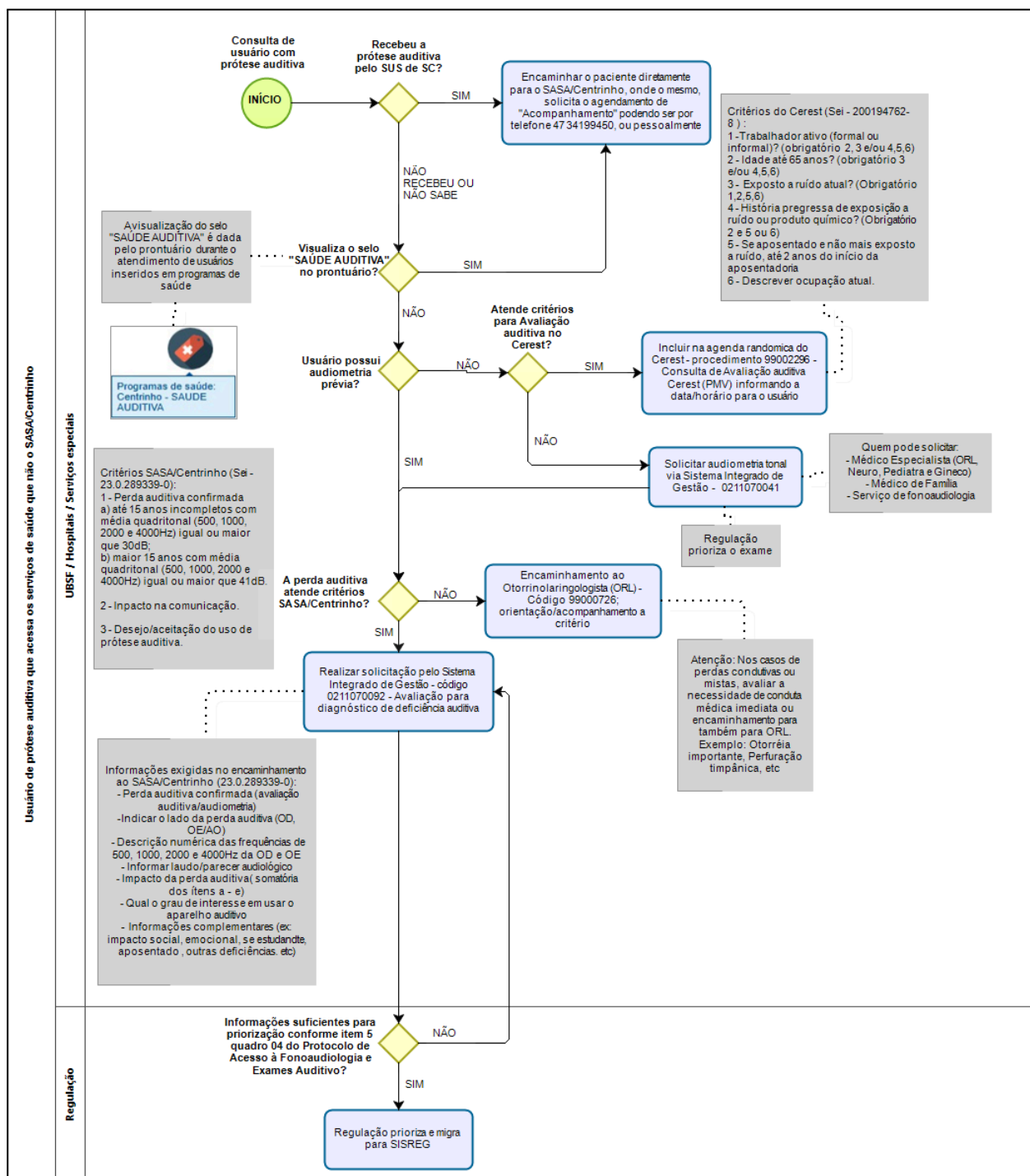
Anexo 01. Fluxo de Acesso à Consulta em Fonoaudiologia



Elaborado: Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos/2025



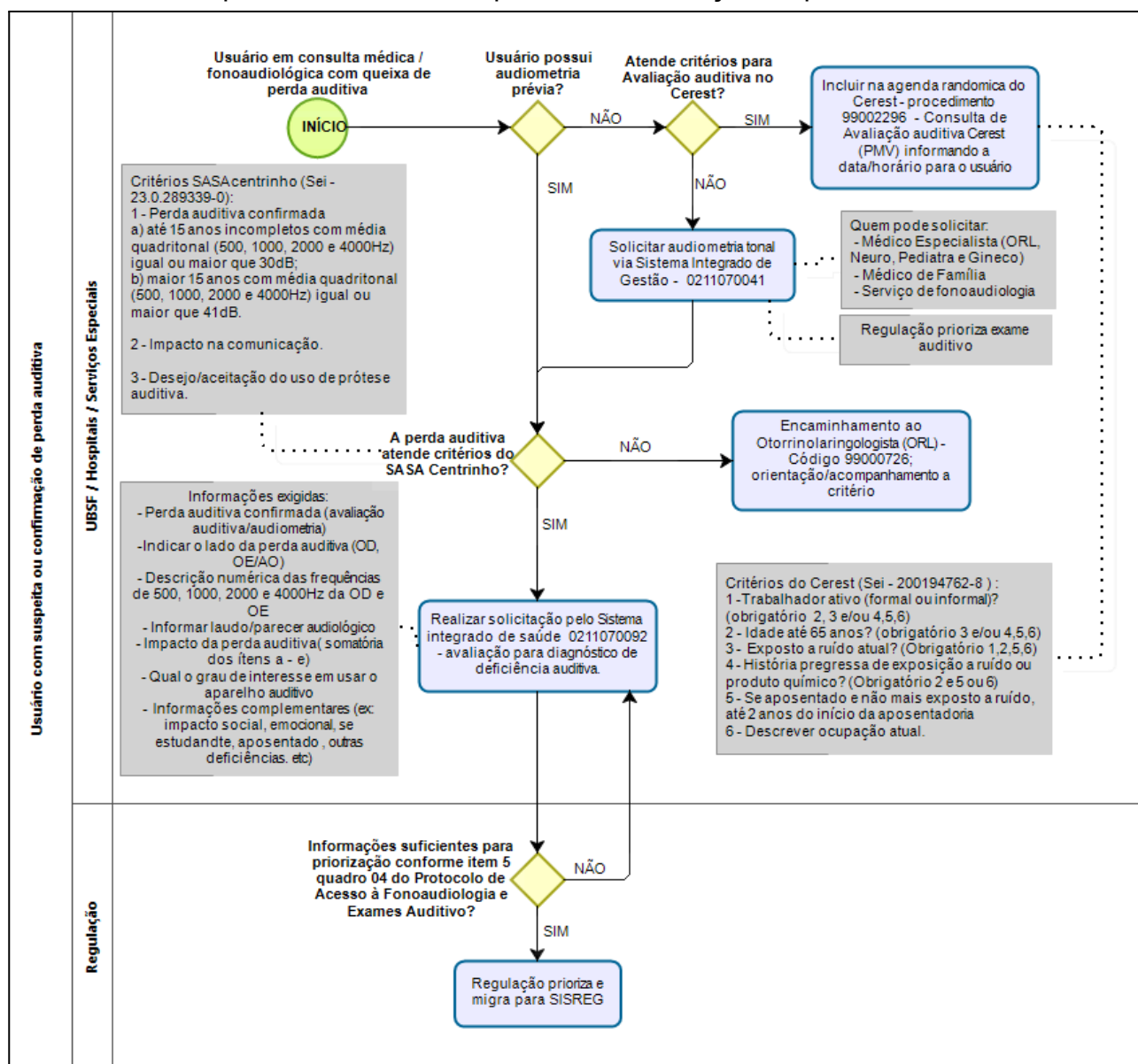
Anexo 02. Fluxo para usuário de prótese auditiva que acessa os serviços de saúde que não o SASA/Centrinho



Elaborado: Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos/2025



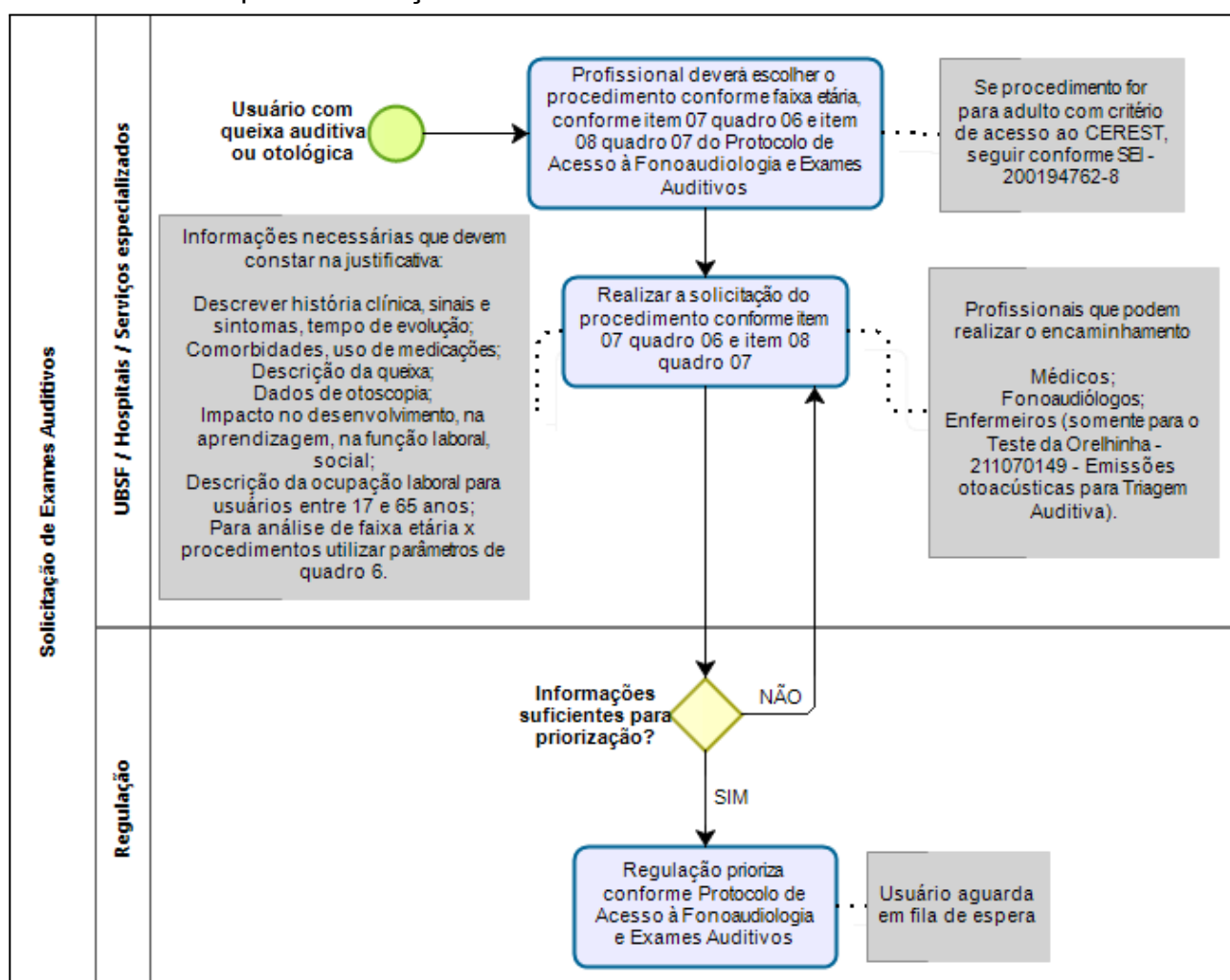
Anexo 03. Fluxo para usuário com suspeita ou confirmação de perda auditiva



Elaborado: Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos/2025

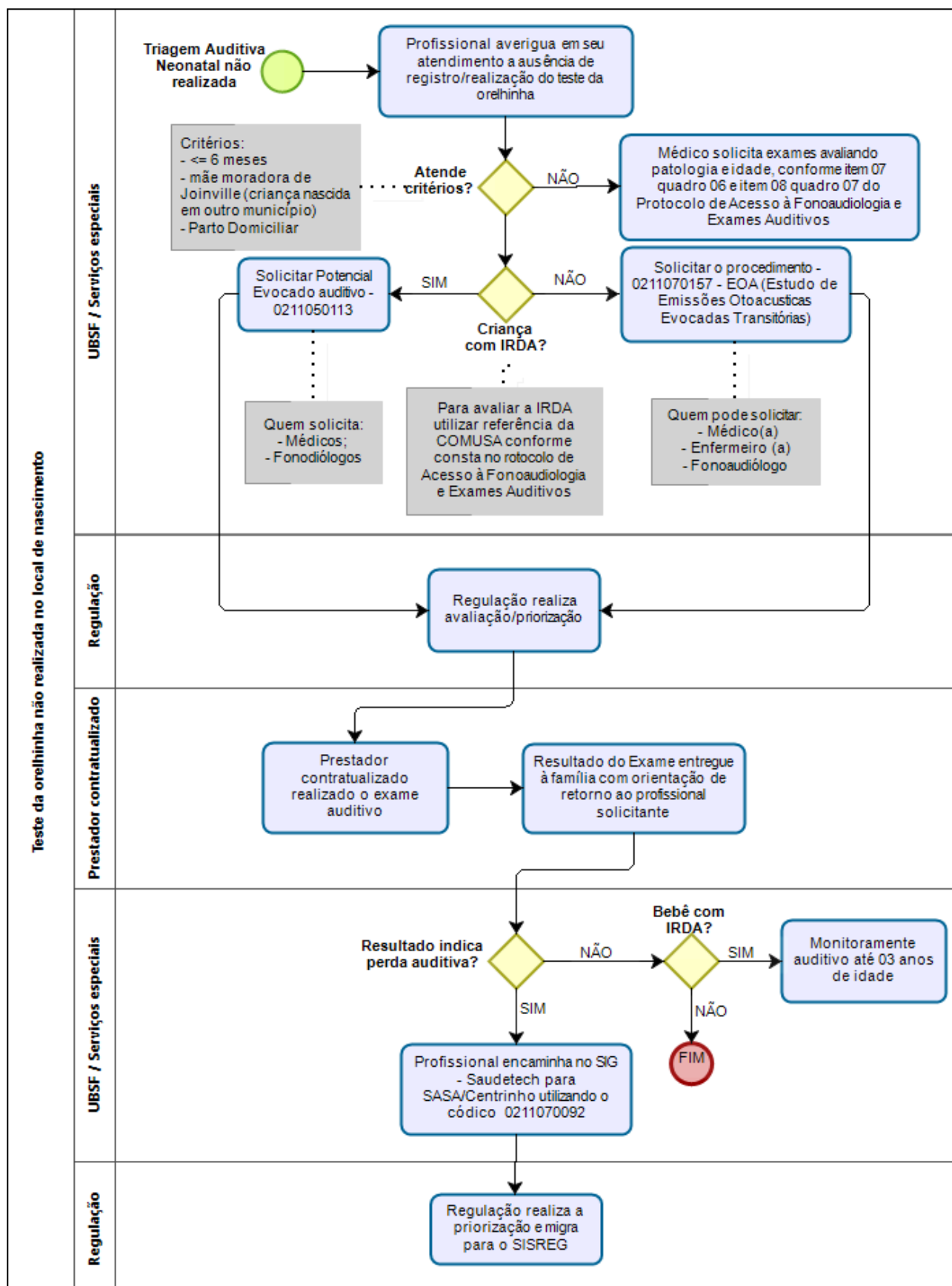


Anexo 04. Fluxo para Solicitação de Exames Auditivos



Elaborado: Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos/2025

Anexo 05. Teste da orelhinha não realizada no local de nascimento



Elaborado: Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos/2025

Anexo 06. Fluxo de usuário identificado com necessidade de frenectomia

